DATO DE ATENCIÓN URGENCIA (DAU)

ESTABLECIMIENTO :	HOSPITAL SAN CARLOS	N°DAU :	3595557
CALIDAD :	Original	FECHA :	18/04/2024 21:31
AREA :	U.E. Adulto	BOX :	4
HC :	2008342412	CTA. CTE. :	0

DATOS CONSULTANTE:

Nombre : FRANCISCA NICOLE ACUÑA BRIONES **RUN** : 19.168.923-2 **CP** : 497422
Previsión : FONASA D **F.Nac** : 11/10/1995 **Género** : Femenino **Edad** : 28 Años 6 Meses 8 Días
Dirección : GOLONDRINAS 0974 V.EL BOSQUE **Comuna** : SAN CARLOS **Teléfono** : 99324465

DATOS INGRESO:

Procedencia : 1_EXTERIOR **Mot. Consulta** : MORBILIDAD COMUN
Lug. Ocurrencia : NO_ESPECIFICADO **Med. Llegada** : A PIE O CAMINANDO

SELECTOR DEMANDA: 1° llamado: 18/04/2024 21:32:25;

Profesional : Cynthia Ortega Molina **Hra. Llamada** : 18/04/2024 21:32 **Hora Atención** : 18/04/2024 21:34
T° Axilar : 0 **T° Rectal** : **Presión** : **Pulso** : 115 **Frec. Resp.** : 0
Saturometría : 98 **HGT** : **Peso** : **Glasgow** : **Clasificación** : C3
Motivo de consulta: : segunda consulta por dolor en fosa derecha, cefalea, fiebre y disnea esta en tto atb con ceftriaxona am no
alergia no
sat 98 fc115 t38.6

CONTROL SIGNOS VITALES:

Fecha	Pulso	Presión	T° Axilar	T° Rectal	FR	Sat.	HGT	Profesional
18/04/2024 22:47			37.2					CAMILA NICOLE MÉNDEZ MORALES
19/04/2024 06:37	78	125/68				99	86	Lorena Hernandez Fuentes
19/04/2024 06:37			36.8					Lorena Hernandez Fuentes

ACCIDENTE, ALCOHOLEMIA Y/O TOXICOLOGIA:

INFORME LESIONES : NO **INFORME ALCOHOLEMIA:** : NO

ANAMNESIS:

Fecha	Anamnesis	Profesional
18/04/2024 21:56	ujer de 28 años, sin antecedentes mórbidos de relevancia ni alergias conocidas. Consulta inicialmente el 16/04/2024 por cuadro de dolor abdominal intenso, sugerente de cólico renal. Al ingreso destaca taquicardia de 120 lpm, afebril, con dolor a la palpación en fosa iliaca derecha, sin signos de irritación peritoneal. Exámenes de laboratorio evidencian PCR elevada de 36.9 mg/L, leucocitosis de 16.700 y función renal conservada. Se realiza TAC de abdomen y pelvis que muestra cálculo ureteral distal derecho de 3 mm que determina leve hidroureteronefrosis ipsilateral, asociado a signos sugerentes de complicación infecciosa. Urocultivo (+) E coli multisensible.	Felix Antonio Sanhueza Luna
19/04/2024 05:38	Se maneja con ceftriaxona ambulatoria, pero persiste con dolor y fiebre. Reconsulta el 18/04/2024 destacando alza de PCR a 152 mg/L. Se realiza nuevo TAC que evidencia zonas de retardo del realce parenquimatoso cortical en riñón derecho, especialmente en tercio superior, asociado a leve trabeculación de espacio graso perirrenal y realce y trabeculación del trayecto ureteral ipsilateral en forma difusa, sugerentes de pielonefritis aguda derecha en evolución, sin colecciones. Leve ascitis en corredera parietocólica derecha y excavación pelviana. Dado cuadro de pielonefritis aguda complicada secundaria a urolitiasis obstructiva, se decide hospitalización domiciliaria para escalar tratamiento antibiótico a ertapenem endovenoso y manejo del dolor.	Felix Antonio Sanhueza Luna

EXAMEN FÍSICO :

Fecha	Examen Físico	Profesional

DIAGNÓSTICOS: **Condición de ingreso:** Conciente

Fecha	Hipótesis diagnóstica	Profesional
19/04/2024 05:38	1. Pielonefritis aguda derecha complicada 2. Urolitiasis ureteral distal derecha obstructiva resuelta 3. Hidroureteronefrosis derecha leve secundaria	Felix Antonio Sanhueza Luna
19/04/2024 05:39	N39.0 INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	Felix Antonio Sanhueza Luna

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y/O TERAPÉUTICOS (TRATAMIENTO EN BOX):

Fecha	Procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos	Profesional	Estado	Responsable
18/04/2024 21:56	ANTIGENO COVID	Felix Antonio Sanhueza Luna	Ejecutado el 18/04/2024 22:37	Cynthia Ortega Molina
18/04/2024 21:59	SS 09% 500 CC EV + KETOPROFENO 200 MG EV	Felix Antonio Sanhueza Luna	Ejecutado el 18/04/2024 22:33	Cynthia Ortega Molina
18/04/2024 23:19	urotac	Felix Antonio Sanhueza Luna	Ejecutado el 19/04/2024 03:53	Paz Valentina Del Solar Reveco
18/04/2024 23:19	ss 09% 1000 cc a chorro	Felix Antonio Sanhueza Luna	Ejecutado el 18/04/2024 23:36	CAMILA NICOLE MÉNDEZ MORALES
19/04/2024 03:58	ertapenem 1 g ev	Felix Antonio Sanhueza Luna	Ejecutado el 19/04/2024 04:33	Paz Valentina Del Solar Reveco

EXAMENES:

Fecha	Examen	Profesional
18/04/2024 21:55	HEMOGRAMA ; GLICEMIA ; UREMIA ; CREATININEMIA ; PERFIL HEPATICO ; PERFIL BIOQUIMICO ; E.L.P. ; PCR ; AC. LACTICO ; OTROS ;	Felix Antonio Sanhueza Luna
19/04/2024 05:51	RCTO GLOBULAR ; GLICEMIA ; UREMIA ; CREATININEMIA ; E.L.P. ; PCR ;	Felix Antonio Sanhueza Luna
18/04/2024 23:15	TC. UROTC CON CONTRASTE	Felix Antonio Sanhueza Luna

INDICACIONES ALTA:

Fecha	Indicación	Profesional
19/04/2024 05:50	Hospitalización domiciliaria Reposo 7 días Regimen liviano Abundantes líquidos, mínimo 2 litros al día. Ertapenem 1g cada 24 horas por 7 dias (evaluar desescalar en función de respuesta clínica) Paracetamol 500 mg 2 comp cada 6 horas vo x 4 dias Ketoprofeno 100 mg 1 cada 8 horas vo x 4 dias Omeprazol 20 mg 1 cada 24 horas vo por 7 dias Hemograma y PCR de control en 48-72 horas Control médico con resultado de examenes Control en urgencia en caso de evolución desfavorable	Cynthia Ortega Molina

RECETAS:

Fecha	Prescripción	Profesional
19/04/2024 05:51	Paracetamol 500 mg 2 comp cada 6 horas vo x 4 dias Ketoprofeno 100 mg 1 cada 8 horas vo x 4 dias Omeprazol 20 mg 1 cada 24 horas vo por 7 dias	Felix Antonio Sanhueza Luna

OBSERVACIONES:

Fecha	Indicación	Profesional
18/04/2024 22:37	SE INSTALA VVP 18 ESI	Cynthia Ortega Molina
19/04/2024 03:18	UROTC Signos tomográficos sugerentes de una Pielonefritis aguda derecha en evolución. Controlar según criterio clínico.	Paz Valentina Del Solar Reveco
19/04/2024 05:50	SE ADMINISTRA 100 MG KETOPROFENO EV MAS 1 GRAMO DE PARACETAMOL VO	Cynthia Ortega Molina
19/04/2024 08:09	Paciente con antecedentes de t de personalidad, sin alergias conocidas, tabaquismo -, oh -, cx -, que consulta n segunda oportunidad en UE por cuadro de dolor en fosa renal derecha, fiebre y cefalea intensa. Inicio el 16/04 con tto ATB con ceftriaxona 2 gramos ev con uroc + e coli multisensible. Al ingreso en regular estado general, febril, con cefalea eva 10, sin signos de alarma. se toma urotac que evidencia PNA, se inicio tto ATB EV DIRECCION GENERAL VENEGAS FAMILIAR RESPONSABLE MARLEN CANDIA ZAPATA 988975127	Cynthia Ortega Molina

GES : No **PERTINENCIA** : Si **DESTINO** : Hospital APS

ADVERTENCIA
ESTE ES UN DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO Y SÓLO UNA PRIMERA ATENCIÓN. DEBE CONSULTAR A SU CENTRO DE SALUD O MÉDICO TRATANTE DENTRO DE LAS 12-24 HORAS SIGUIENTES. SI SUS SÍNTOMAS EMPEORAN, CONSULTE NUEVAMENTE A LA BREVEDAD. ES SU RESPONSABILIDAD SEGUIR ESTAS INDICACIONES.

LLAME A SALUD RESPONDE
600·360·7777
PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS DUDAS LAS 24 HORAS, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

www.hospitalsancarlos.cl
Fono: +56 42 2586130

ORIGINAL: PACIENTE
248105211158

MANUEL VALDES SALGADO
13.859.840-3